체형분석 보고서

DR.PMA · POSTURE ANALYSIS REPORT

연구코드
견본-001

성별 · 나이	키	몸무게	자세	측정일	측정자
남 · 54세	172cm	71kg	서서	2026.10.15	견본 (S01)

78 /100

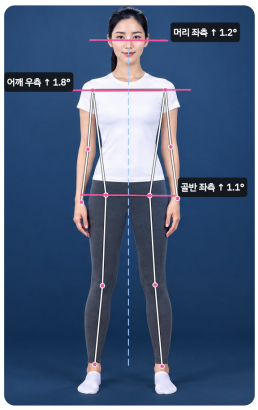
자세 정렬 지수

3단계 · 치우침이 진행된 상태

직전 측정과 촬영 방향이 달라 비교하지 않음

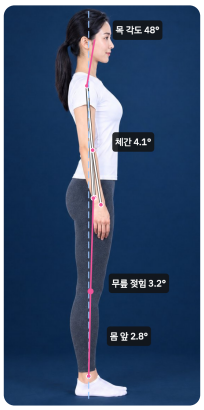
참고용 지수 · 진단 아님 · 계산 방법은 뒤쪽

정면 FRONT



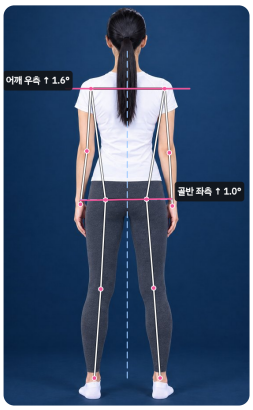
머리 기울기	좌↑ 1.2°·1.0mm	유지
어깨 높이	우↑ 1.8°·1.5mm	경계
골반 높이	좌↑ 1.1°·2.3mm	유지
몸통 치우침	좌 3%	유지
좌 무릎 축	바깥쪽 2°	유지
우 무릎 축	바깥쪽 3°	유지
전신 기울기	좌로 1.4°	경계

우측면 SIDE



목 각도	48°	유지
어깨 앞뒤	앞 8%	경계
몸통 전후	뒤 4.1°	경계
몸 전후	앞 2.8°	경계
무릎 펴짐	젖힘 3.2°	경계
줄어든 키	0.40cm	참고

후면 BACK



어깨 높이	우↑ 1.6°·0.2mm	경계
골반 높이	좌↑ 1.0°·3.0mm	유지
몸통 치우침	좌 2%	유지
전신 기울기	좌로 1.2°	경계
골반 높이 차	구분 안 됨(1cm 미만)	참고

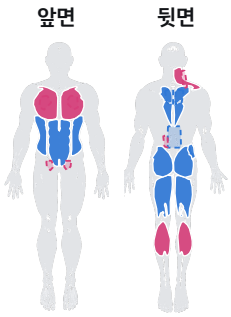
부위별 점수

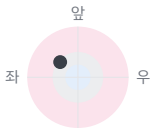
머리·목	■■■■■■■■■	88
어깨	■■■■■■■	66
체간	■■■■■■■■	73
골반	■■■■■■■■■	83
무릎	■■■■■■■■■	84

먼저 볼 부위

1. **상체가 수직에서 4.1° 기움**
   체간 · 59점
2. **어깨가 귀보다 앞으로 나옴(8%)**
   어깨 · 60점
3. **어깨 우측이 1.7° 높음**
   어깨 · 72점

근육 지도 · 몸 균형





앞 2.8° · 좌 1.4°

이번에 나온 근육

늘일 근육 장요근(고관절 앞) · 장딴지근(종아리) · 우측 상부 승모근 · 우측 견갑거근 · 소흉근 · 대흉근(가슴) · 좌측 요방형근(허리 옆)

강화할 근육 대둔근(엉덩이) · 하부 승모근 · 중부 승모근 · 능형근(날개뼈 사이) · 척추 기립근(허리 뒤) · 복사근(옆구리) · 복부 근육 · 우측 중둔근(엉덩이 옆) · 햄스트링(허벅지 뒤)

할 운동

늘이기	가슴 펴기	30초 × 3회
늘이기	고관절 앞 늘이기	30초 × 3회
늘이기	목 옆 늘이기	30초 × 3회
강화	힙 힌지	12회 × 3세트

유지 허용폭 절반 이내 · 경계 허용폭 이내 · 위험 허용폭 초과. 허용폭은 이 앱의 잠정 기준이며 진단이 아닙니다.

Dr.PMA · pma.drwon.kr

사진 위의 분홍 선과 점은 사진에서 잡은 관절 자리이고, 파란 점선은 기준(몸의 가운데·수평)입니다. 좌우는 대상자 기준입니다(좌↑ = 대상자의 좌측이 높음).

소견과 추천 운동

DR.PMA · FINDINGS & EXERCISES

연구코드
견본-001

경계·위험으로 나온 6개 항목입니다. 나머지 6개 항목은 유지 범위입니다.

● 늘일 근육 (짧아지기 쉬움) ● 강화할 근육 (약해지기 쉬움)

무릎이 뒤로 3.2° 젖혀짐(과신전)

경계

무릎을 뒤로 잠가 서는 모양(과신전)입니다. 허벅지 뒤·엉덩이 근육이 약해 무릎을 살짝 굽힌 채 버티지 못하고, 관절 끝에 기대 서는 경우가 많습니다.

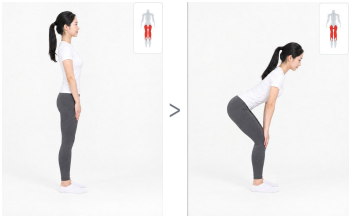
늘일 근육

장딴지근(종아리)

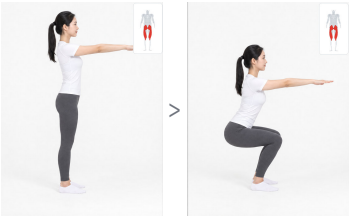
강화할 근육

햄스트링(허벅지 뒤) 대둔근(엉덩이)

흔히 보이는 경우: 무릎을 뒤로 잠그고 서는 습관, 허벅지 뒤·엉덩이 근육 약화, 관절이 유연한 체질



강화 **힙 힌지**
12회 × 3세트
등은 펴고 엉덩이를 뒤로 빼며 숙이기



강화 **스쿼트**
10회 × 3세트
엉덩이를 뒤로 빼고 무릎이 발끝 방향으로

상체가 수직에서 4.1° 기움

경계

상체가 뒤로 젖혀진 모양입니다. 허리 뒤 근육이 당기고 복부 깊은 근육이 약한 경우가 많습니다.

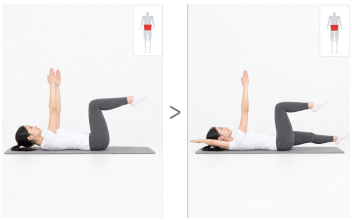
늘일 근육

척추 기립근(허리 뒤)

강화할 근육

복부 심부 근육

흔히 보이는 경우: 오래 앉아 고관절 앞이 짧아진 경우, 복부·엉덩이 근육 약화



강화 **데드버그**
10회 × 2세트
허리를 바닥에 붙인 채 팔·다리 반대로 뻗기



강화 **브릿지**
12회 × 3세트
엉덩이를 조이며 어깨-무릎 일직선까지 들기

어깨가 귀보다 앞으로 나옴(8%)

경계

가슴 근육이 짧아져 어깨를 앞으로 말고, 날개뼈를 뒤로 모아주는 등 근육이 약해 끌어오지 못하는 모양(둥근 어깨)일 수 있습니다.

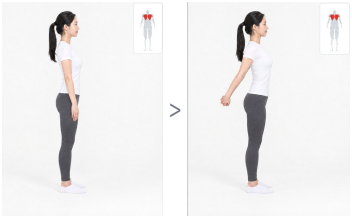
늘일 근육

대흉근(가슴) 소흉근

강화할 근육

중부 승모근 하부 승모근 능형근(날개뼈 사이)

흔히 보이는 경우: 오래 앉아 구부정한 자세, 가슴 운동에 비해 등 운동이 적은 경우



늘이기 **가슴 펴기**
30초 × 3회
등 뒤로 깍지 끼고 어깨를 뒤로, 가슴을 위로



강화 **밴드 로우**
12회 × 3세트
팔꿈치를 몸 옆으로 당기며 날개뼈 모으기

몸 전체가 좌측으로 1.3° 기울어 섬

경계

몸 전체가 좌측으로 기울어 체중이 한쪽에 실린 모양입니다. 옆구리 근육과 우측 엉덩이 옆 근육(중둔근)이 몸을 가운데로 세워 주지 못하는 경우가 많습니다.

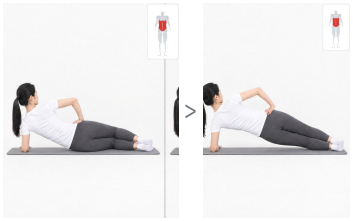
늘일 근육

좌측 요방형근(허리 옆)

강화할 근육

복사근(옆구리) 우측 중둔근(엉덩이 옆)

흔히 보이는 경우: 한쪽 다리에 체중을 싣고 서는 습관, 한쪽 다리·발목 통증을 피하는 자세



강화 **사이드 플랭크**

20초 × 3회(양쪽)

머리부터 발까지 일직선, 골반이 처지지 않게



강화 **한 발 서기**

20초 × 3회(양쪽)

골반이 한쪽으로 빠지지 않게 버티기

몸 전체가 발목보다 앞으로 2.8° 쏠림

경계

몸 전체가 발목보다 앞으로 쏠린 모양입니다. 종아리·고관절 앞 근육이 짧고, 몸을 뒤에서 받치는 엉덩이·등 근육이 약한 경우가 많습니다.

늘일 근육

장딴지근(종아리) 장요근(고관절 앞)

강화할 근육

대둔근(엉덩이) 척추 기립근(허리 뒤)

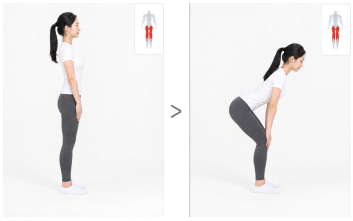
흔히 보이는 경우: 체중을 앞꿈치(또는 뒤꿈치)에 싣고 서는 습관, 종아리·고관절 앞 근육이 짧아진 경우



늘이기 **고관절 앞 늘이기**

30초 × 3회

한쪽 무릎 꿇고 골반을 앞으로 밀기



강화 **힙 힌지**

12회 × 3세트

등은 펴고 엉덩이를 뒤로 빼며 숙이기

어깨 우측이 1.7° 높음

경계

우측 어깨를 끌어올리는 근육(상부 승모근·견갑거근)이 짧아져 있고, 날개뼈를 아래로 내려 주는 하부 승모근이 약한 모양일 수 있습니다.

늘일 근육

우측 상부 승모근 우측 견갑거근

강화할 근육

하부 승모근

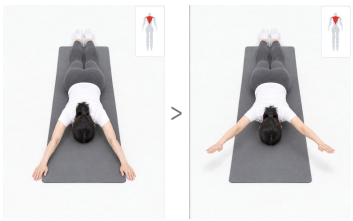
흔히 보이는 경우: 가방을 늘 같은 쪽에 메는 습관, 골반 높이 차이를 몸이 보상한 결과



늘이기 **목 옆 늘이기**

30초 × 3회

반대쪽으로 머리를 기울이고 손으로 살짝 당기기



강화 **엎드려 Y 들기**

10회 × 2세트

엄지를 위로, 날개뼈를 아래로 모으며 팔 들기

근육과 운동은 이런 자세에서 흔히 쓰는 교정운동 원칙에 따른 일반적인 안내이며 개인 처방이 아닙니다. 사진으로는 어느 근육이 실제로 짧거나 약한지 알 수 없습니다. 통증이 있으면 멈추고 전문가와 상의하세요. | 목 각도(CVA): 목 아래(C7)와 귀를 이은 선이 수평선과 이루는 각. 클수록 머리가 바로 선 것이고, 50° 미만이면 머리가 앞으로 나온 편입니다. 골반 높이 차(참고): 입력한 키로 사진 크기를 cm로 환산한 어림값입니다. 다리 길이 차이의 가능성을 보는 참고용이며, 짝다리·근육 긴장으로도 생깁니다. 정확도는 아직 검증 전이라 1cm 단위 구간으로만 적습니다.

Dr.PMA · pma.drwon.kr

보행분석 보고서

DR.PMA · GAIT ANALYSIS REPORT

연구코드
견본-001

성별	나이	키	측정일	측정자	바닥	카메라	찍은 방향
남	54세	172cm	2026.10.15	S01	지면보행	고정	정면 **후면** **좌측** **우측**

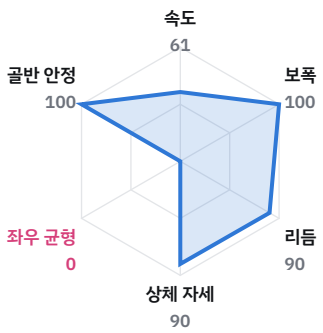
74 /100

종합 점수(참고) · 속도·보폭·리듬·상체 자세·좌우 균형·골반 안정 평균

걸을 때 좌측 골반이 더 내려갑니다 · 상체를 앞으로 9° 숙이고 걷습니다

아래 운동 2가지를 권합니다

걸음 균형



바깥으로 넓을수록 기준에 가깝습니다 · ㅡ는 못 잰 항목

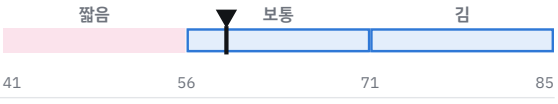
핵심 지표

가운데 칸 = 같은 성·연령 평균±1SD · 속도는 0.8·1.0 m/s 경계 · ▼ 이번 값

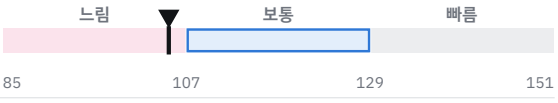
보행속도 (Gait speed)
기준 남 50~59세 평균 1.43
1.03 m/s



보폭 (Step length)
기준 50~84세 63±7 cm
59 cm



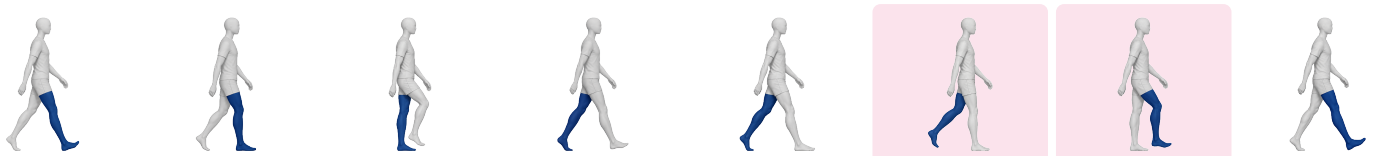
분속수 (Cadence)
기준 50~84세 118±11 걸음/분
105 걸음/분



보행주기 1.15초(한 발이 닿고 다시 닿을 때까지) · SPPB 보행 4/4점

걷는 동작 — 한 걸음 8구간

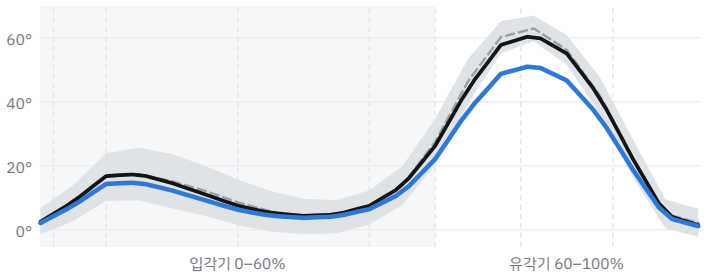
숫자 = 그 구간 가운데의 무릎 굽힘 좌·우(°) · 핑크 = 정상 평균±1SD 밖



초기접지	부하반응	중간입각	말기입각	전유각	초기유각	중간유각	말기유각
3·4	9·10	12·15	4·4	12·14	41·48	47·55	9·10

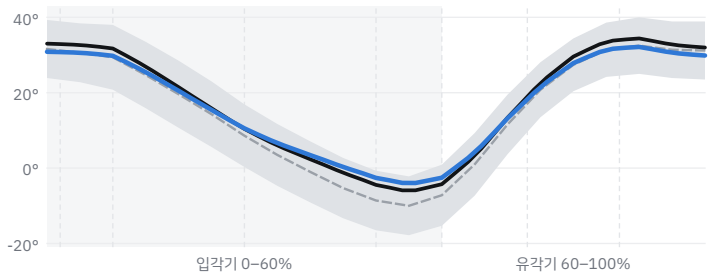
무릎 굽힘

— 좌 — 우 · 회색 = 정상 평균±1SD · 굽힘 ↑



고관절 굴곡

— 좌 — 우 · 회색 = 정상 평균±1SD · 굴곡 ↑ · 폄 ↓



측정 항목

좌·우는 대상자 기준 · 핑크 = 확인할 값 · 정상 = 같은 연령대 동작분석실 값

항목	좌측	우측	차이	참고
골반 하강	6.8°	3.1°	3.7°	2° 이상 차이면 확인
팔 흔들기	31°	38°	7.0°	기준 없음
무릎 최대 굽힘	52°	61°	9.0°	정상 63±4°
무릎 펴짐	3°	1°	2.0°	0° 안팎
고관절 굴신 범위	36°	41°	5.0°	정상 40~43°

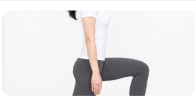
항목	값
상체 앞 기울기	9.1°
골반 흔들림 폭	13.5°
상체 좌우 흔들림	7.2°
보행주기	1.15초
SPPB 보행	4/4점

1 **걸을 때 좌측 골반이 더 내려갑니다.**
우측 다리로 디딜 때 골반을 받쳐 주는 우측 중둔근(엉덩이 옆 근육)이 약해지기 쉬운 모양입니다(트렌델렌버그 소견).



옆으로 누워 다리 들기
15회 × 3세트

2 **상체를 앞으로 9° 숙이고 걷습니다.**
고관절 앞 근육(장요근)이 짧아지고 엉덩이·등 근육이 약해지기 쉬운 모양입니다.



고관절 앞 늘이기
30초 × 3회

기준: Bohannon & Williams Andrews 2011 · Studenski 외 2011 · AWGS 2019(Chen 외 2020) · SPPB(Guralnik 1994) · Fukuchi 외 2018 · Jung 외 2023 · 구간 Perry & Burnfield. 곡선·무릎 정상값은 동작분석실 값이라 카메라 값과 차이가 날 수 있습니다. 점수 판 G1 · 참고용·진단 아님.

관절가동범위 보고서

DR.PMA · RANGE OF MOTION

연구코드
견본-001

측정일	거리 · 높이	측정자	다음 측정	측정 방식
2026.10.15	250 · 100cm	S01	4주 뒤	카메라 10동작

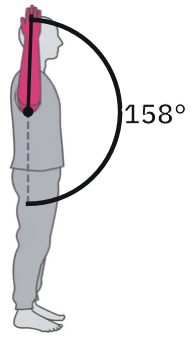
89 점 · B

관절가동범위 종합 · 참고값 AAOS 성인 가동범위 · B 양호

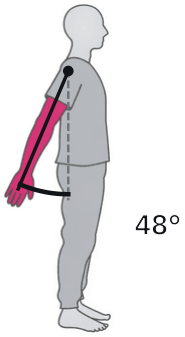
관절 7곳 중 4곳이 참고값에 닿았습니다 · 발목이 가장 좁습니다

좌우 차이는 어깨 굴곡(16°)이 가장 큽니다 · 4주 뒤 같은 조건으로 다시 재기

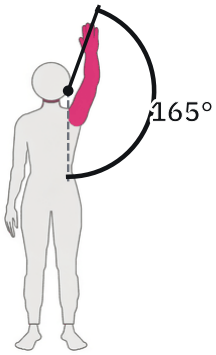
어깨 제한 — 83점



굴곡
좌 158° 우 142° /180

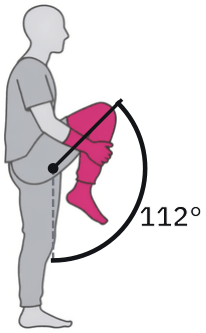


신전
좌 48° 우 44° /60

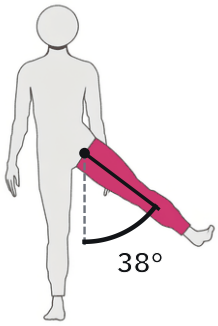


외전
좌 165° 우 151° /180

고관절 주의 — 92점

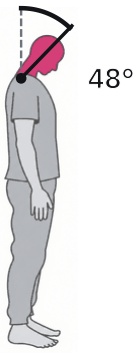


굴곡
좌 112° 우 118° /120



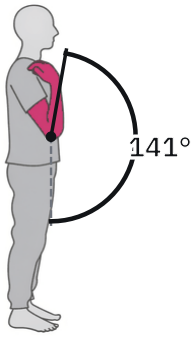
외전
좌 38° 우 41° /45

목 정상 — 100



굴곡
좌 48° 우 47° /45

팔꿈치 정상 — 93



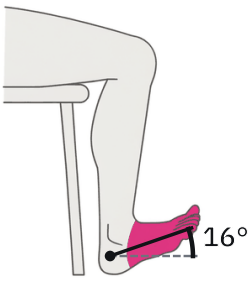
굴곡
좌 141° 우 139° /150

무릎 정상 — 99



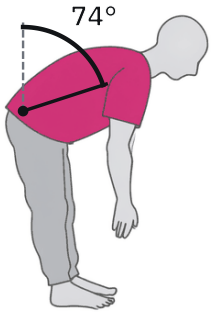
굴곡
좌 132° 우 136° /135

발목 제한 — 73



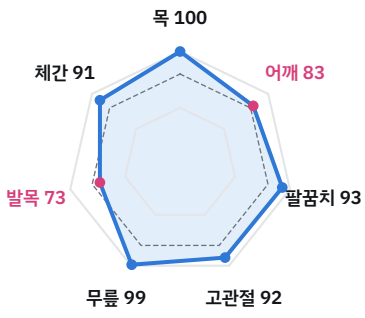
배측굴곡
좌 16° 우 13° /20

체간 정상 — 91



굴곡
좌 74° 우 72° /80

부위별 점수



할 운동

좁은 관절을 늘리는 운동 · 주 5회

어깨 83점



벽 슬라이드
등·팔꿈치·손등을 벽에 붙인 채 팔 올리기
10회 × 2세트



가슴 펴기
등 뒤로 깍지 끼고 어깨를 뒤로, 가슴을 위로
30초 × 3회

고관절 92점



고관절 앞 늘이기
한쪽 무릎 꿇고 골반을 앞으로 밀기
30초 × 3회



옆으로 누워 다리 들기
발끝은 앞을 향하게, 골반이 뒤로 돌지 않게
15회 × 3세트

발목 73점



카프 레이즈
뒤꿈치를 천천히 들었다 더 천천히 내리기
15회 × 3세트



수건 당기기
발가락으로 수건을 뒤꿈치 쪽으로 끌어오기
15회 × 3세트

종합 소견 전체 가동범위는 89점(B 양호)입니다. 관절 7곳 가운데 4곳이 참고값에 닿았습니다. 낮은 곳은 어깨 83점, 고관절 92점, 발목 73점입니다. 그 가운데 발목 배측굴곡이 우측에서 참고값의 65%로 가장 좁습니다. 카프 레이즈·수건 당기기를 주 5회 하십시오. 좌우 차이는 어깨 굴곡에서 16°로 가장 큽니다. 좁은 쪽을 더 하십시오. 4주 뒤 같은 조건으로 다시 재어 변화를 보십시오.

큰 숫자 = 잰 각도 · /숫자 = 참고값(AAOS 계열 성인 가동범위, 각도계 값). 핑크 = 참고값의 80% 미만(제한) · 주의 80~89% · 정상 90% 이상. 카메라 추정이라 각도계와 체계적 차이가 있을 수 있어, 못 미친다고 제한이 있다는 뜻은 아닙니다. 점수는 좌·우를 참고값으로 나눈 비율의 평균이며 넘긴 만큼은 세지 않습니다(A 90↑ · B 80~89 · C 70~79 · D 70↓). 같은 조건으로 잰 값끼리의 변화를 보십시오. 의료기기가 아닙니다.

운동 보고서

DR.PMA · EXERCISE REPORT

연구코드
견본-001

보고일	기간	처방 기준	권장	측정자
2026.10.15	9.18 ~ 10.15	체형 · 관절가동범위	주 5회	S01

10 일 / 28일

지난 4주 운동 · 앱에 기록된 운동만 셉니다(체력측정은 빼고)

주 2.5회 했습니다 · 권장(주 5회)의 50%

평균 힘든 정도 5.2/10 · 가장 아팠을 때 3/10

4주 달력 · 칠한 날 = 운동한 날

18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15

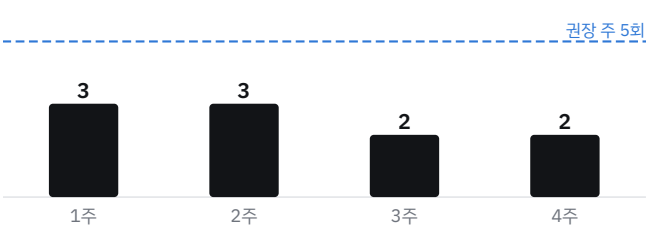
운동별 기록

최근 10.12까지 4주 · 지난번과 비교 · 좋아진 값 블루 · 주의할 값 핑크

운동	처방	한 횟수·시간	지난번	동작 깊이(최고)	목표	힘듦	통증
벽 슬라이드 양쪽 · 10.12	10회 × 2세트	30회	24회	141°	145°	6	1
카프 레이즈 좌측 · 10.12	15회 × 3세트	28회	30회	117°	125°	7	3
가슴 펴기 좌측 · 10.12	30초 × 3회	90초	90초	–	–	3	0
브릿지 좌측 · 10.12	12회 × 3세트	36회	33회	–	–	5	0
힙 힌지 좌측 · 10.12	12회 × 3세트	36회	30회	118°	115°	6	0

운동한 양 · 주별

7일씩 · 운동한 날 수



체력측정

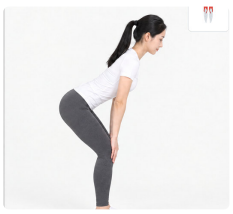
10.15 · 기준은 국민체력100 어르신 자료가 있는 검사만

30초 의자 앉았다 일어서기 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	14 회
눈 감고 한발서기 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	11.4 초
제자리 점프 체공시간 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	0.41 초
1분 스쿼트 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	27 회

정리 4주 동안 **10일** 운동했습니다(주 2.5회, 권장 주 5회). 앞 2주 6일, 뒤 2주 4일로 줄었습니다. 지난번보다 횟수·시간이나 동작 깊이가 는 운동은 **벽 슬라이드, 브릿지, 힙 힌지**입니다. 횟수·시간이 준 운동은 **카프 레이즈**입니다. 목표 각도(잠정값)에 못 미친 운동은 **벽 슬라이드(141°/145°), 카프 레이즈(117°/125°), 힙 힌지(118°/115°)**입니다. 통증이 기록된 운동은 **벽 슬라이드(1/10), 카프 레이즈(3/10)**입니다 — 통증이 없는 범위로 횟수나 세트를 줄이고, 통증이 이어지면 전문가와 상의하십시오. 다음 4주도 **주 5회**를 목표로 하십시오.

다음 4주 운동

체형·관절가동범위 결과에 맞춘 처방 · 주 5회



강화
힙 힌지
12회 × 3세트



강화
스쿼트
10회 × 3세트



늘이기
고관절 앞 늘이기
30초 × 3회



강화
브릿지
12회 × 3세트



늘이기
가슴 펴기
30초 × 3회



강화
밴드 로우
12회 × 3세트

운동 기록은 앱에서 운동할 때 자동으로 남은 것만 셉니다. 처방은 앱의 기본 처방량입니다. 동작 깊이·목표 각도는 잠정값이며 참고범위가 아닙니다. "지난번"은 같은 종목의 바로 전 기록이며, 촬영 거리·높이가 다르면 각도는 견주지 않았습니다. 기준: 국민체력100 어르신 측정자료(공공데이터포털, 2013~2026, 40만 6천 건)에서 계산한 성·연령대별 백분위. 인증 등급이 아니라 자료 안에서의 상대 위치입니다. 의료기기가 아닙니다.